EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77381
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2024-01-15 11:00:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	:ELSA DEL CARMEN APARICIO CARO			RUN	:7.098.619-1
F.Nac	:17-03-1954	Edad	:69 AÑOS, 9 MESES	Género	:Femenino
Dirección	:			Comuna	:SAN CARLOS
Previsión	:SIN INFORMACION	Teléfono	:0		
Fecha Ingreso	:2024-01-11	Fecha Egreso	:2024-01-15 11:00:00	Causal	:MEDICA
Condición	:VIVO	Destino	:HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R07.2-DOLOR PRECORDIAL

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Doble Lesión Aórtica (estenosis e insuficiencia) Resuelta
- Reemplazo Valvular Aórtico con prótesis PERCEVAL-L, más plastía mitral con anillo N°30 y cierre de orejuela izquierda
- Insuficiencia mitral moderada
- Delirium hipoactivo resuelto
- HTA | DM2 | ACV antiguo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I34.0-INSUFICIENCIA (DE LA VALVULA) MITRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa al servicio de medicina DEL HCHM el 10/01 tras retornar de HLH posterior a cirugía cardiaca. Cuenta con historia de disnea de esfuerzos progresiva, hasta el reposo. Se realiza ecocardiograma el 30/01/23 que reporta doble lesión aórtica, estenosis e insuficiencia severa. Realizan coronariografía el 21/02/23 que no describe lesiones. El 04/01/2024 se realiza RVAO con prótesis PERCEVAL-L, más plastía mitral con anillo N°30 y cierre de orejuela izquierda en HLH. Evoluciona favorablemente, con destete rápido de DVA, extubación precoz, exámenes generales normales sin disfunciones orgánicas. Destaca en evolución post operatoria delirium hipoactivo, fue evaluada por neurología solicita TAC de cerebro que describe lesiones de ACV secuelares, nada nuevo. Indica observación y control SOS por especialidad. Por lo que se decide traslado a nuestro centro para continuidad de tratamiento. Ingresa en BCG, sin apremio respiratorio, sin requerimientos de O2, con HDN estable, bien perfundida.
Derivada a nuestro centro para completar periodo de observación y continuar rehabilitación cardiovascular. Actualmente, orientada TE, bien hidratada y perfundida, refiere menor dolor en zona de inserción quirúrgica, herida sin signos de sobreinfección.
Evolucionando favorablemente , kinesioterapia bien tolerada, Sin necesidades de oxigeno.
En buenas condiciones generales Estable Afebril Sin dolor en reposo.
yugulares planas, tórax mp presente con crepitos dispersos , mp disminuido en base, herida operatoria limpia , sin secreciones
eeii sin edema, neurologico vigil orientada sin focalizacion Neurologica.
se indica lata HODOM

PLAN DE MANEJO:

HODOM
KNT respiratoria
Control al alta por cardiología (IC hecha)
Control poli cradiologia en 15 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. Régimen: Hiposódico – Diabético, hidratación por boca
2. Aspirina 100 mg/día VO
3. Atorvastatina 40 mg/día VO
4. Losartán 50 mg cada 12h VO
5. Amlodipino 10 mg/día VO
6. Carvedilol 6.25 mg cada 12h VO
7. Paracetamol 1g cada 8h VO
8. Dabigatran 110 mg cada 12 horas vo
9.
10. KNT respiratoria
11. Control al alta por cardiología (IC hecha)
12. Control poli cardiología en 15 dias
13. Avisar eventualidad

EXÁMENES Y RESULTADOS

Glicemia : 257 * mg/dl 74 - 106
Creatinina : 0,60 mg/dl 0,52 - 1,04
Acido Urico : 3,90 mg/dL 2,50 - 6,20
Calcio : 8,8 mg/dL 8,4 - 10,2
Fosfatasa Alcalina : 109 U/L 38 - 126
Bilirrubina Indirecta : 0,48 mg/dL < 1,10
Bilirrubina Directa : 0,12 mg/dL < 0,30
Bilirrubina Total : 0,60 mg/dL 0,20 - 1,30
ASAT/GOT : 21 U/L 14 - 36
ALAT/GPT : 26 U/L < 35
Gama GT : 43 U/L 12 - 43
Colesterol Total : 104 mg/dL < 200
HDL Colesterol : 30 * mg/dL > 40
LDL Colesterol : 47 * mg/dL 50 - 115
VLDL Colesterol : 26,60 mg/dL 2,00 - 30,00
Clearence Calculado(MDRD) : 99,1
Proteina C Reactiva : 84,4

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO